

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5017163-59.2025.4.02.5101/RJ**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

**RECORRENTE:** JONATHAN PEREIRA ALVES

**RECORRIDO:** ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RECORRIDO:** MUNICÍPIO DE NITERÓI

**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**SAÚDE. CANABIDIOL. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS INSUFICIENTES. MANIFESTAÇÃO DO NAT DESTACANDO A NECESSIDADE DE PESQUISAS MAIS RIGOROSAS PARA ESTABELECEER PERFIS DE SEGURANÇA E EFICÁCIA CLAROS. IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO FORNECER MEDICAMENTO OU PRODUTOS EXPERIMENTAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.**

**ACÓRDÃO**

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a Recorrente nas verbas sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Publique-se. Intime-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5017163-59.2025.4.02.5101

510015752061 .V4

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5017163-59.2025.4.02.5101/RJ**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

**RECORRENTE:** JONATHAN PEREIRA ALVES

**RECORRIDO:** ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RECORRIDO:** MUNICÍPIO DE NITERÓI

**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**RELATÓRIO**

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão, *verbis*: (evento 39, DESPADEC1)

*"Trata-se de ação por meio da qual a parte autora requer o fornecimento contínuo do medicamento "Canabidiol Greencare solução oral 23,75 mg/ml".*

*Alega ser portadora de "TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) INFANTIL".*

*Salienta-se que o STF, por meio das Súmulas Vinculantes de números 60 e 61, tornou obrigatória aos Juízes e Tribunais a observância das teses firmadas nos Temas 6 e 1.234, conforme determinação constante do art. 927 do CPC. Esses Temas tratam de medicamentos com registro na ANVISA, mas não disponibilizados pelo SUS.*

*O Tema 6 estabeleceu critérios mais rigorosos para a aquisição dos medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas que não constem nas listas do Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que admitidos apenas excepcionalmente, conforme parâmetros nele definidos:*

*"(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral;*

*(b) ilegalidade da não incorporação do medicamento pela CONITEC; ausência do pedido de incorporação ou mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;*

*(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e terapêuticos;*

(d) comprovação, à luz de evidências científicas seguras, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado;

(f) incapacidade financeira do requerente de arcar com o custeio do medicamento."

Já o Tema 1.234, indicou critérios sobre a compra desses medicamentos e qual o ente federativo deve assumir a responsabilidade, de acordo com valor.

*De acordo com o Tema 1234, são medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS, medicamentos previstos nos protocolos clínicos oficiais para outras finalidades, medicamentos sem registro na Anvisa e medicamentos off label sem protocolo clínico ou que não integrem listas do componente básico).*

*No caso dos autos, conforme Parecer do NAT juntado ao Evento20, o produto requerido nos autos está registrado na ANVISA, no entanto, não está padronizado para dispensação através do SUS.*

Neste sentido, cumpre informar que dentre os produtos à base de **Canabidiol** registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), consta registro de **Canabidiol 23,75mg/mL Greencare<sup>®</sup>**, contudo o referido produto não está padronizado em nenhuma lista oficial de medicamentos dispensados através do SUS (Componentes Básico, Estratégico e Especializado), no âmbito do município de Niterói e do Estado do Rio de Janeiro. Logo, não cabe seu fornecimento a nenhuma das esferas de gestão do SUS.

O MPF, no Parecer de Evento 36, manifestou-se pela procedência dos pedidos.

*Cumpra-se asseverar que, nos termos do art. 196 da Constituição da República (CRFB/1988), a saúde é direito de todos e dever do Estado, representando, assim, uma garantia constitucional para o indivíduo. Vale destacar que o art. 198 da CRFB/1988, ao dispor sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece que este será financiado pela União, Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade solidária dos referidos entes públicos.*

*No entanto, nos termos dos Temas acima citados, tratando-se de medicamento não incorporado, como no caso dos autos, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, dentre outros requisitos.*

*Conforme informações prestadas pela DPU, foi efetuado o requerimento administrativo (a), mas a parte autora não obteve resposta (Evento 1, ANEXO1, fls. 3 e 8):*

#### PRETENSÃO

A MÃE DO MENOR COMPARECEU NESTA UNIDADE PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA PARA OBTENÇÃO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL SOL. ORAL 40 MG/ML. A REQUERENTE ALEGA QUE NÃO FOI POSSÍVEL OBTER O MEDICAMENTO DESTA FORMULAÇÃO NA REDE PRIVADA, E QUE NÃO OBTVEU RESPOSTA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO SUS; E QUE A CRIANÇA ENCONTRA-SE SEM A MEDICAÇÃO.

*Dos laudos de Evento 1, anexo2, fl. 5 e anexo3, fl. 9, consta que a parte autora já recebeu "vários medicamentos" e que o canabidiol é recomendado, uma vez que a resposta inicial foi considerada bastante favorável.*

*A incapacidade financeira (f) restou comprovada. A parte autora recebe o Benefício de Prestação Continuada a Pessoa com Deficiência, cujos requisitos são a hipossuficiência e a deficiência (Evento 1, ANEXO3).*

*Do Parecer do NAT, juntado ao Evento 20, constam os seguintes esclarecimentos:*

*"(...) no que concerne ao nível de evidência, faz-se importante elucidar que em uma revisão sistemática os métodos utilizados visam minimizar fontes de viesamento, possibilitando a obtenção de resultados mais fiáveis e conclusões mais robustas. A posição ocupada pela revisão sistemática na hierarquia da evidência revela a sua importância para a investigação clínica<sup>2</sup>. Nessa hierarquia, quando exploramos a evidência sobre a eficácia de uma intervenção ou tratamento, as revisões sistemáticas de ensaios controlados aleatorizados (com ou sem metanálise) tendem geralmente a disponibilizar a evidência mais forte, ou seja, é a abordagem mais adequada para responder a questões sobre a eficácia de uma intervenção. Dito isto, apenas estudos de revisão sistemática foram considerados para confecção do presente parecer técnico."*

*"Uma revisão sistemática sem metanálise elaborada conforme as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), apontou que existe evidências de que o canabidiol (CBD) possa reduzir os sintomas do transtorno do espectro do autismo (TEA). Contudo, os pesquisadores destacaram que a segurança e eficácia desse tratamento estão atualmente em estudo. A heterogeneidade dos resultados em pesquisas sugere a necessidade de estudos mais abrangentes e de longo prazo<sup>3</sup>."*

*"Outro estudo utilizando a mesma metodologia descrita acima concluiu que a Cannabis e os canabinoides têm efeitos muito promissores no manejo do TEA e podem ser usados no futuro como uma importante opção terapêutica para esta condição, especialmente crises de automutilação e raiva, hiperatividade, problemas de sono, ansiedade, inquietação, agitação psicomotora, irritabilidade e agressividade. No entanto, ensaios clínicos randomizados, duplo-cegos e controlados por placebo, bem como estudos longitudinais, são necessários para esclarecer os achados sobre os efeitos da Cannabis e seus canabinoides em indivíduos com autismo<sup>4</sup>."*

*“Ainda mais recente (2024) e mantendo a mesma diretriz dos estudos anteriores – PRISMA, Jawed e colaboradores concluíram que embora existam evidências crescentes sugerindo que o canabidiol possa auxiliar no manejo dos sintomas do TEA, avaliar sua eficácia continua sendo um trabalho complexo devido a evidências limitadas. Apesar dos resultados positivos observados nos estudos, discrepâncias na composição dos produtos, dose e respostas individuais destacam a necessidade de abordagens de tratamentos personalizados<sup>5</sup>.”*

*“Assim, fundamentado pelos achados científicos expostos, este Núcleo conclui que as evidências atuais são limitadas e inconsistentes, destacando a necessidade de pesquisas mais rigorosas para estabelecer perfis de segurança e eficácia claros”.*

*“Acrescenta-se ainda que em Parecer técnico-científico, elaborado em dezembro de 2023 pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde – Hospital Sírio Libanês (NATS-HSL), no qual foram avaliados derivados da Cannabis e seus análogos sintéticos para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Foi identificada evidência de baixa certeza de que o extrato de planta integral de Cannabis pode aumentar a proporção de pacientes com melhor escore global de sintomas em 12 semanas quando comparado ao placebo. O efeito do extrato purificado neste mesmo desfecho é incerto. A certeza da evidência foi rebaixada devido a problemas metodológicos e baixo tamanho amostral nos estudos incluídos. Adicionalmente, não foram encontrados estudos que avaliaram os efeitos da Cannabis quando comparada a outras tecnologias, como a risperidona, presente no SUS<sup>6</sup>.”*

*“Para o tratamento do Autismo, o Ministério da Saúde atualizou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo<sup>7</sup>, preconizando o fármaco Risperidona solução oral de 1mg/mL (para doses que exigem frações de 0,5mg) e comprimidos de 1, 2 e 3mg. Por conseguinte, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), atualmente disponibiliza, no CEAF, o medicamento Risperidona 1mg e 2mg (comprimidos).”*

*“Cabe ressaltar ainda que o PCDT faz referência ao Canabidiol, mencionando que foram encontrados 1 estudo clínico e 09 estudos observacionais. Para o estudo clínico, os resultados ainda são preliminares e, os estudos observacionais, possuem limitações para recomendar o uso clínico, reforçando que estudos clínicos randomizados são necessários, assim não foi possível formular recomendação sobre o uso de canabidiol no tratamento do comportamento agressivo no TEA”*

*“Segundo relato médico (Evento 1 ANEXO3, Página 9), o Autor “...Já fez tratamento com Risperidona, Levomepromazina (Neozine®), Valproato de Sódio (Depakene®) e Canabidiol 50mg/mL, com resultados insatisfatórios”. Portanto, o medicamento padronizado, a saber Risperidona, já foi empregado no plano terapêutico do Autor.”*

*“O produto pleiteado Canabidiol 23,75mg/mL Greencare® até o momento não foi submetido à análise da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde (CONITEC-MS)<sup>8</sup>.”*

*“Conforme a autorização, o Canabidiol poderá ser prescrito quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro. A indicação e a forma de uso dos produtos à base de Cannabis são de responsabilidade do médico assistente.”*

**No presente caso, não ficou comprovado o cumprimento dos requisitos do Tema 6, em especial, a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, à luz de evidências científicas seguras.**

*De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.*

*Considerando que os documentos juntados aos autos não demonstram os requisitos acima citados, indefiro, por ora, o requerimento de tutela de urgência.*

*Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 5 dias.*

*Remetam-se os autos ao MPF.*

*Nada sendo requerido, aguarde-se o prazo para contestação e voltem-me os autos conclusos.”*

*É o breve relatório.*

## **VOTO**

Inicialmente, quanto à legitimidade passiva e à solidariedade dos entes públicos federativos, *verbis*:

**“Processo** RESp 1203244 / SC RECURSO ESPECIAL 2010/0137528-8

**Relator(a)** Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)

**Órgão Julgador** S1 - PRIMEIRA SEÇÃO

**Data do Julgamento** 09/04/2014

## **Ementa**

PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE **MEDICAMENTOS**. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de **medicamentos** ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado o por obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ.

**2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional", razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida" (RE**

**607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011).** Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

## **Acórdão**

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA Seção do Superior Tribunal de Justiça: "A Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator." Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Ari Pargendler e Arnaldo Esteves Lima votaram com o Sr. Ministro Relator. Sustentaram, oralmente, os Drs. SÉRGIO LAGUNA PEREIRA, pelo recorrente, e DANIELLE ALEIXO REIS DO VALLE SOUZA, pela União.

## **Notas**

Julgado conforme procedimento previsto para os **Recursos Repetitivos** no âmbito do STJ. Veja os **EDcl no REsp 1203244-SC** que foram acolhidos."

Assim, os cidadãos podem postular a concessão de medicamentos, insumos e, por analogia, procedimentos médicos de todos os órgãos federados.

Foi realizada, corretamente, a intimação do Núcleo de Assistência Técnica, NAT, para emissão de parecer, nos termos do que dispõe o Enunciado 13 do CNJ: "Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde - SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)"

O NAT juntou parecer no processo 5012901-97.2024.4.02.5102/RJ, evento 20, PARECER1.

Nos termos do parecer do NAT:

"Assim, fundamentado pelos achados científicos expostos, este Núcleo conclui que **as evidências atuais são limitadas e inconsistentes**, destacando a necessidade de pesquisas mais rigorosas para estabelecer perfis de segurança e eficácia claros."

O Enunciado nº 83 do CNJ ressalva a importância de evidência científica na análise do pedido.

Colhe-se do enunciado:

"Poderá a autoridade judicial determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a juntada ao processo de documentos de evidência científica (nota técnica ou parecer) disponíveis no e NatJus (CNJ) ou em bancos de dados dos Núcleos de Assessoramento Técnico em Saúde (NATS) de cada estado, desde que relacionados ao mesmo medicamento, terapia ou produto requerido pela parte."

O Tema 106 estabeleceu a necessidade do cumprimento de certos requisitos, no caso de medicamentos não incorporados ao SUS:

### **TEMA 106 - MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS - REQUISITOS**

*"Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS".*

*Tese Firmada: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:*

*i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*

*ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*

*iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".*

Ainda, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 657718, pela sistemática da repercussão geral (tema 500), em acórdão publicado no DJE nº 117, divulgado em 31/05/2019. Na ocasião, o Supremo fixou as seguintes teses:

*"1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.*

*2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.*

*3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.*

*4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União."*

Além de não constar na tese fixada qualquer referência a questão do fornecimento de medicamentos para uso *off label*, é possível se extrair do voto vista do Exmo. Ministro Dias Toffoli as seguintes considerações:

*"Faço, por fim, três ponderações.*

*A primeira: a conclusão a que se chegou nestes autos quanto ao registro na ANVISA como condição necessária ao fornecimento da medicação pelo SUS não se relaciona com a hipótese de fornecimento off label do medicamento, hipótese na qual o fármaco é registrado na agência, mas o uso requerido foge da indicação contemplada em sua bula.*

*Embora a ANVISA proceda ao registro dos medicamentos para específica finalidade, não se pode afirmar que, por isso, o medicamento, quando indicado para finalidade diversa, não conta com registro da agência reguladora. O registro em tal caso existe. O uso do medicamento é que está dissociado da indicação para a qual foi registrado.*

*Assim, a celeuma que se dá quanto à possibilidade de se obrigar o sistema a fornecer medicação para indicação diversa da registrada na ANVISA - hipótese que também conta com vedação legal expressa no art. 19-T, I, da Lei nº 8.080/90 - não se refere à travada aqui nestes autos.*

*Digo isso apenas para esclarecer o alcance do que está sob julgamento nos presentes autos, de modo que essa espécie de apreciação seja realizada nos autos adequadamente."*

A tese fixada no Tema 106 do C. STJ é no sentido de que o fornecimento de medicamentos deve observar a *"existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência"*.

Essa Turma Recursal, em processos análogos, firmou o entendimento que diante de evidências científicas insuficientes resta caracterizada a impossibilidade do Estado em fornecer medicamentos ou produtos experimentais.

**SAUDE. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 200 MG/ML. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS INSUFICIENTES. MANIFESTAÇÃO DO NAT E DA FIOCRUZ PELA NECESSIDADE DE ESTUDOS. IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO FORNECER MEDICAMENTO OU PRODUTOS EXPERIMENTAIS. TEMA 500 DO STF.** (Sessão do 23/05/2023, Sessão Virtual, Processo 31 da Pauta, Processo nº 5004147-56.2021.4.02.5108. Rel. Dra. Daniella Motta)

Por fim, considero expressamente prequestionados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, aos quais inexiste violação.

Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a Recorrente nas verbas sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Publique-se. Intime-se.

---

5017163-59.2025.4.02.5101

510015752060 .V6